

Información Paciente

Nombre : Bernardina Del Rosario Mondaca Aguile	Rut : 9.399.889-8	N° Archivo : A632769	N° Epicrisis : 443121
Edad : 61a 7m 16d	Fecha Nacto : 20/10/1963	Sexo : Femenino	
Dirección : Psj/Playa Amarilla 3779 V/El Arraya	Comuna : Puente Alto	Teléfono : 999309905 930941210	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto	Fecha Ingreso : 27/04/2025 07:29	Días Estadía : 39
Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)	Fecha Egreso : 05/06/2025 17:06	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES

- Médicos: Traqueobroncomalacia con indicación de BIPAP nocturno (sin uso VMNI hace 1 año), Asma grave (con crisis graves que han requerido IOT en 2 ocasiones), DM2 IR, HTA, Obesidad.
- Quirúrgicos: TQT 2014, Colectistectomía 2012
- Fármacos: Budesonida 2 puff con aerocámara c/12 hrs, Br Ipratropio/fenoterol 2 puff con aerocámara 3 veces al día + 2puff SOS, Olodaterol/tiotropio 2.5/2.5 mcgr 2 inhalaciones 1 vez al día
- Alergias: PENICILINA (anafilaxia), Ceftriaxona (rash)
- Hábitos: Tabaco (-), OH (-), drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes:
 - 2022 Crisis de Asma Severa, NAC, Soporte VMI.
 - Jun 2024 Crisis de Asma moderada, NAC, Soporte VMNI
- Social: Dueña de casa, vive con esposo. Jubilada a los 40 años, pensión de invalidez.

ANAMNESIS

Consulta por cuadro de 24 hrs de evolución caracterizado por disnea progresiva, tos productiva y cianosis peribucal. Niega fiebre, exposición a humo u otros descompensantes.

A su ingreso a urgencia vigil, cooperadora, taquicardica y taquipneica. Al examen físico se describe MP disminuido con crépitos y sibilancias difusas. Se inicia manejo con broncodilatadores, corticoides y se solicita estudio con TC 27/04 que muestra Condensación con componente atelectásico segmentario basal en LII, lingular y en segmentos dependientes del LSD. Se rescata Panel viral (+) Influenza A.

Se inicia manejo médico de asma. Por mala mecánica se conecta a VMI V/C previo consentimiento verbal, requiriendo Noradrenalina 0.2. En ese contexto se traslada a UPC.

LABORATORIO INGRESO

27/04: crea 1.7, láctico 47, glucosa 495, PCR 92, GSA 7.12, pCO2 59.7, pO2 120, HCO3 19.

Microbiología:

Panel viral (+) Influenza A, COVID (-), HC (-), UC (-), CAET (-).

Fecha Epicrisis : 05/06/2025 12:23

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

1. Insuficiencia respiratoria aguda global
 - IOT 27/04
 - Crisis asmática severa
2. Shock séptico foco pulmonar
 - Neumonía de la comunidad grave por Influenza A (+)
3. AKI KDIGO II
4. Hiperglucemia no CAD no SHH
5. Antecedentes

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS

Hemodinamia: Al ingreso con requerimientos de noradrenalina hasta 0.2 ug/kg/min por shock séptico foco pulmonar. Buena respuesta a volemicación, logra suspensión precoz de drogas vasoactivas. Posteriormente hipertensa por lo que se reinician vasodilatadores orales, sin conflicto perfusional.

Ventilatorio: Antecedentes de asma severa, triple terapia inhalatoria, PFP con importante restricción, con indicación de uso de BIPAP por traqueobroncomalacia y roncopatía, sin polisomnograma (pendiente estudio ambulatorio), sin embargo sin uso de VMNI hace 1 año (refiere que se quemó dispositivo). Ingresó nuevamente por crisis asmática severa con necesidad de VMI, se realiza intubación orotraqueal (IOT) el 27/04, se inician corticoides sistémicos y broncodilatación. Extubada el 04/05, sale a VMNI. Evoluciona con crisis obstructiva sin respuesta a broncodilatadores, magnesio ni adrenalina, siendo reintubada el 07/05 y posteriormente extubada el 14/05. Sale a VMNI intercalado con CNAF, posteriormente naricera. Se ajusta terapia inhalatoria LAMA/LABA, SABA/SAMA, ICS y antihistamínico (obs patrón Th2). Se inicia titulación de BPAP nocturno, con apoyo de rehabilitación kinésica. Suspende oxígeno el 25/05. Dado requerimientos prolongados de corticoides EV (recibe por 28 días), se inicia decalaje cauteloso de prednisona asociado a profilaxis.

Con indicación de BPAP nocturno, discutido con equipo de broncopulmonar, se decide ingreso a programa AVNIA. Se realiza ventana de VMNI por 72 hrs, con control de gases arteriales adecuados, sin retención de CO₂, por lo que equipo de broncopulmonar sugiere alta sin VMNI a la espera de entrega de dispositivo por programa AVNIA. Control ambulatorio por broncopulmonar.

Infeccioso: Shock séptico de foco pulmonar secundario a neumonía por Influenza A. Del estudio microbiológico destaca: COVID (-), HC (-), UC (-), CAET (-). Se inició terapia con Oseltamivir por 5 días asociado a terapia antibiótica empírica con ceftriaxona y azitromicina (rash por ceftriaxona conocido, sin RAM en esta estadía), completando 7 días.

- El 5/5 cursa con bacteriemia por E Coli R a ciprofloxacino. Inicialmente recibe Imipenem de forma empírica, que posteriormente se ajusta a ceftriaxona según susceptibilidad, completando 7 días.

Renal: Ingresó con insuficiencia renal aguda prerrenal en contexto de shock. Buena respuesta a volemicación. Sin mayor conflicto.

Metabólico: Crisis hiperglucémica no CAD no SHH, se maneja con BIC insulina y nutrición enteral en UPC. Con glicemias estables pasa a esquema basal correccional. HbA1c 7.3%. Evoluciona con buen control metabólico. Al alta seguimiento en CESFAM.

Rehabilitación: Multimodal. En lo motor deambula con mínima asistencia. En lo fonoaudiológico sin restricción de consistencias, pero se mantiene en rehabilitación con terapia de voz. Tiene pendiente evaluación por otorrino, se gestionará en ambulatorio.

LABORATORIO

02/06 GSA pH 7.43 PCO₂ 32.7 PO₂ 98 HCO₃ 21.2 BE -3.1 SAT O₂ 97

30/5: Na/K/Cl 140/3.98/108 Ph 7.45 PCO₂ 26.9 HCO₃ 18.5 Crea 0.64 BUN 11.9

IMAGENOLOGÍA

08/05 TAC TAP: Nuevos signos de bronquiolititis celular pulmonares bilaterales y pequeños focos de relleno alveolar en LID, de probable etiología inflamatoria infecciosa. - Tráquea broncomalacia central con atelectasia completa del LII.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria aguda global, resuelta

Fecha Última Actualización: 05-06-2025 12:23:26

Página 3 de 4

- Crisis asmática severa
- IOT (27/04 al 04/05) - Reintubación (07/05 al 14/05)
- 2. Shock séptico foco pulmonar resuelto
- Neumonía por Influenza A
- 3. Bacteriemia por E coli tratada (ceftriaxona 7 días)
- 4.Crisis hiperglicémica no CAD/SHH, resuelta
- 5. AKI KDIGO II prerrenal resuelta
- 6. Antecedentes

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria Aguda - Neumonía

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

En buenas condiciones generales, hemodinamia estable, afebril, sin requerimientos de oxígeno. Deambula con asistencia mínima. En condiciones de alta a domicilio con UHD para continuar en terapia fonoaudiológica y kinésica.

Plan Post Alta

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA

Reposo relativo, asistido.

Régimen sin restricción de consistencia, acompañar almuerzo y cena con sopa para favorecer humedad de alimento

Terapia por fonoaudiología

Kinesoterapia motora y respiratoria

MEDICAMENTOS

Prednisona 10 mg según el siguiente esquema de decalaje:

- 1 comprimido (10 mg) al día por 5 días (hasta el 09/06 incluido)

- Luego 5 mg al día por 1 semana (desde el 10/06 hasta el 16/06 incluido)

- Luego 2.5 mg al día por 1 semana y suspender (desde el 17/06 hasta el 23/06 incluido)

Cotrimoxazol forte 1 comprimido los días Lu-Mi-Vi vía oral (Suspender al término de prednisona el día 23/06)

Berodual 2 puff cada 8 hrs por aerocámara

Budesonida 2 puff cada 12 horas por aerocámara

Olodaterol/tiotropio 2,5/2,5 mcg 2 inhalaciones al día

Omeprazol 20 mg al día vía oral

Clorfenamina 4 mg en la noche vía oral

Losartan 25 mg cada 12 hrs vía oral

Atorvastatina 20 mg c/día vía oral

Metformina 850 mg cada 12 hrs vía oral

Insulina NPH 12 unidades AM y 4 unidades PM

CONTROLES

- Control médico por broncopulmonar en Centro de tratamiento (CDT) Hospital Sotero del Río, solicitar hora con epicrisis al alta.

- Control por otorrinolaringología para estudio de disfonía severa post IOT. Solicitar hora con interconsulta

- Seguimiento de DM2, HTA en CESFAM. Evaluar ajuste de terapia según evolución.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 05/06/2025 12:23

Página 3 de 4

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 05-06-2025 12:23:26

Página 4 de 4



Bec. Fernando Descalzi Rojas

Becado/Residente

Mayra Javiera Gaete Verdugo

Médico Tratante (Staff)

INTERNO